Diskussion 473

Datum: 1924-05-09
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Ivan Pauli (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Vad kammaren här har att taga ställning till är ju icke närmast den detaljfråga, som herr Wahlmark på utskottets vägnar huvudsakligen behandlat, utan det är det stora och för hela folkets hygien så yttersi viktiga spörsmålet om en verklig folktandvård, d. v. s. om det lämpligaste sättet att åstadkomma den bästa möjliga tandvård åt det största möjliga antalet svenska medborgare. För att man skull kunna nå det största möjliga antalet, måste det givetvis också vara en såvitt möjligt billig och lätt tillgänglig tandvård.

Såsom framgår av den utförliga motivering, andra kammarens utskott givit sitt utlåtande, har denna fråga många gånger i olika former varit uppe inom riksdagen, utan att man kommit till något avgörande. Det måste särskilt beklagas, att när 1917 till följd av ett föregående riksdagsbeslut en vidlyftig och synnerligen grundlig utredning angående tandvården bland skolungdomen hade kommit till stånd, denna utredning under de många år, som sedan dess gått, fått ligga på hyllan och ej på något sätt kommit till användning. När alltså de många debatter, som i riksdagen under de senare åren förts i denna fråga, icke lett till något praktiskt resultat, är det så mycket viktigare, att riksdagens kamrar nu se till att få till stånd ett beslut, som verkligen kan åstadkomma en utredning och leda till att något faktiskt blir gjort.

Det var för att åstadkomma ett sådant enhetligt beslut, som min medreservant nyss framlade det yrkande, som han formulerade, och jag kommer att för min del instämma i detta yrkande.
|

Han framhöll i sitt första anförande, att tandvården för mycket länge sedan har passerat det hantverksmässiga stadiet och numera måste betraktas såsom en integrerande del av läkarvetenskapen, såsom en specialitet av denna. I själva verket kan ju den bästa möjliga tandvård endast åstadkommas därigenom, att den

hålles uppe på den högsta möjliga vetenskapliga nivå. Det ha vi också här i landet sökt göra, och icke minst har tandläkarkåren själv på ett synnerligen berömvärt sätt strävat efter att höja yrkets vetenskapliga nivå och få till stånd en utbildning för yrkets utövare, som kan ge en

garanti i detta avseende. Det verkade ganska egendomligt på mig och, förmodar jag, på många andra, att se denna lovvärda strävan från tandläkarna framställas rent av som ett illasinnat försök att överkvalificera tandvården, såsom i motiveringen till den här i kammaren framlagda motionen.

Jag skall icke gå närmare in på orsakerna, varför tandvården måste ha denna vetenskapliga karaktär. Jag vill endast uttala ett beklagande av att icke flera av kammarens ledamöter ansett sig ha tid och tillfälle att besiktiga det nya tandläkarinstitutets lokaler under de dagar de voro inbjudna att göra detta. För min del efterkom jag med nöje denna uppmaning, och jag får säga, att jag fick tillfälle att se åtskilliga saker där uppe, som än mer än förut stärkte min övertygelse, att här verkligen behöves den största och grundligaste möjliga insikt för att komma till ett gott resultat. Det första fall, som kom under mina ögon där, och som förevisades av min ciceron, var ett fall av s. k. tandlossning, och röntgenplåten visade, att denna lossning av tänderna berodde på en långt gången s. k. nedsmältning av käkbenet. Orsakerna till detta fenomen äro, som vi veta, ännu långt ifrån ordentligt utredda, men tack vare röntgenfotograferingen och de metoder, man för närvarande tillämpar, kan man dock till en viss grad bekämpa detta onda. I varje fall är det alldeles nödvändigt att kunna ställa diagnosen på dylika åkommor, och för att ställa diagnosen och rätta den följande behandlingen efter denna diagnos måste man ha en insikt om anatomiska och fysiologiska ting, som sannerligen ej förvärvas på det lättvindiga sättet, att man inköper vissa utländska läroböcker och studerar dem på egen hand.

Att, såsom 1 tandteknikernas inlaga av år 1919 framhölls, man skulle försöka företaga en uppdelning i de fall, varvid ingen risk hotade patienten, och i de fall, där sådan risk tydligen hotade honom, är för dem, som sökt sätta sig in i frågan, alldeles otänkbart. Var skall man draga gränsen mellan de riskfyllda och de riskfria fallen? Herr Wahlmark talade nyss om, att tandteknikerna borde få dessa enklare fall överlåtna på sig. Jag fick aldrig höra, vilka fall han därmed avsåg, men det skulle vara mycket intressant att få veta, var han egentligen drager denna gräns.

Tandläkarinstitutet i sitt nuvarande skick är det tydligaste arbetsresultatet av denna mångåriga strävan att höja tandläkaryrkets nivå här i landet. Dessutom har den omgestaltning, i vilken tandläkarinstitutet tack vare riksdagens beslut befinner sig sedan fjolåret, också betydelse för den andra sidan av frågan, nämligen hur man med tandvården skall nå största möjliga antal patienter. En av de mest betydande svårigheterna härvidlag har varit den tandläkarbrist, som man ju måste erkänna har rått och fortfarande råder här i landet, och tillika de höga taxor, som tandläkarna tillämpa. Tandläkarbristen ha vi nu goda utsikter att få avhjälpt inom en relativt nära framtid, ty utbildningskapaciteten hos tandläkarinstitutet, som tidigare endast belöpte sig till 30 utexaminerade elever per år, har nu ökats till 80 och kan utan svårighet inom den närmaste framtiden ökas till 95. Om riksdagen så önskar, kan man dessutom genom att utrymma de lokaler, som etnografiska museet för närvarande har upplåtna till uppackningslokaler, vinna ett så högst betydligt ökat utrymme,

att ett mycket större antal elever per år kan utexamineras, utan att det kommer att kosta statsverket något avsevärt — kanske en engångskostnad av, tror jag, 20,000 kronor och en årlig kostnad av 10,000 kronor eller något däröver. Resten betalar institutets egen drift samt de avgifter, som eleverna erlägga. På det sättet komma vi alltså att relativt snart få en utökad tandläkarkår här i landet och en i följd därav ökad konkurrens,

som ovillkorligen i någon mån måste medföra en sänkning av taxorna och dessutom; förse våra avlägsna bygder med tandläkare. Men det är alldeles tydligt

även om det blir ökad konkurrens, att med den höga utbildningskostnad, som

detta yrke fordrar, vården i enskild praktik fortfarande kommer att ställa sig alldeles för dyr för ett mycket stort antal personer här i landet i mindre bemedlade eller obemedlade omständigheter.

Vad är då att göra? Det synes uppenbart, att man först och främst måste tänka sig en anordning i analogi med den, som vi sedan länge träffat i fråga om den allmänna sjukvården. Man har inom den allmänna sjukvården icke tillgripit den utvägen att sänka kompetensen och skapa en mindre kvalificerad läkarkår jämte den högre kvalificerade, utan man har hållit fordringarna uppe och genom statsoch kommunalunderstödda lasarett och kliniker, genom inrättande av stadsoch provinsialläkartjänster och på annat sätt ordnat det så, att även den fattigaste människa här i landet kan få åtnjuta förstklassig läkarvård till ringa eller alls ingen kostnad. Jag menar, liksom andra kammarens utskott och andra kammaren genom sitt beslut uttalat, att detta är den väg, som vi närmast ha att slå in på.

Det säges nu av herr Wahlmark, att det icke behövs något statsingripande för att få kliniker till stånd. Det har herr Wahlmark alldeles rätt i, och det bör här framhållas gent emot dem, som förmena, att vår svenska tandläkarkår handlat uteslutande ur egoistiska affärssynpunkter, att tandläkarföreningen i Stockholm har på eget initiativ inrättat tre försökskliniker för mindre bemedlade patienter, där dessa få sina tänder omskötta för betydligt billigare pris än 1 privat praktik. Och det är uteslutande Stockholms stads ensak, huruvida dessa kliniker i sinom tid skola övergå i kommunens händer eller icke.

Det är alldeles riktigt, såsom det framhålles i andra kammarens andra tillfälliga utskotts motivering, att tandvården måste börja med barnen. Det första vi måste tänka på, är inrättandet av skolkliniker, ty om barnens tänder skötas 1 tid, innebär detta en alldeles ofantlig besparing i fråga om den framtida tandvården. Skolkliniker kunna emellertid utan någon svårighet apteras till folkkliniker. Man kan till exempel tänka sig, att de på förmiddagen användas för skolbarnens räkning och på eftermiddagen för övriga patienters räkning. Vid dessa kliniker måste man givetvis tänka sig att man utom tandläkarna använder väl utbildade hjälpkrafter; man har närmast tänkt sig tandsköterskor i analogi med **sjuksköterskorna**[3] på den allmänna sjukvårdens område. Därför mena vi reservanter 1 likhet med andra kammaren,

att utbildningen av sådana tandsköterskor är en av de angelägenheter, som den blivande utredningen bör taga om händer, och naturligtvis måste den också taga under övervägande en mera metodisk utbildning av laboratoriebiträden eller, som de också kallas, tandtekniker. Med avseende på de stora, glest befolkade trakterna i Norrland, där jag vet att man alldeles särskilt känner bristen på tandvård, skulle man möjligen kunna tänka sig ett slags ambulerande tandkliniker. När vi nu här på kamrarnas bord ha en motion, där det ifrågasättes att, bland annat, övervinna de långa skolvägarnas besvärligheter genom att forsla skolbarnen i skolomnibusar, kan man kanske våga uttala den utopiska tanken, att man skulle kunna aptera automobilomnibusar till ambulerande tandkliniker med full utrustning, och jag tycker för min del, att det icke är någon oäven tanke.

Jag skall nu be att med några ord få beröra den Bobergska motionen, som herr Wahlmark gjort sig till talesman för. När han talar om, att det är oriktigt, att endast 70 tandtekniker här skulle kunna komma i fråga, och att det i själva verket är omkring 200, så får man väl i alla fall icke ifrågasätta, att samtliga tandtekniker, som finnas i landet, skulle kunna komma i fråga till legitimation, utan det skulle väl endast vara det antal som är, som de själva

kalla sig, »självpraktiserande» och alltså äga någon övning 1 det yrke de göra anspråk på att bliva berättigade att utöva. I varje fall, även om de skulle vara något mera än detta 70-tal — jag ber att få fästa herr Wahlmarks uppmärksamhet på att denna uppgift ytterst stammar från tandteknikerna själva — så måste man dock säga sig, att, när man har en utbildningskapacitet hos tandläkarinstitutet på 80 å 95 stycken elever per år, så kan ett antal s. k. självpraktiserande tandtekniker, som knappast uppgår till denna summa, icke betyda något vidare, när det är fråga om ett förbilligande av tandvården. Man bör dessutom tänka på att dessa tandtekniker, som nu begära att bli legitimerade, icke heller skulle innebära något tillskott i fråga om arbetande yrkesutövare. De äro ju samtliga redan i full verksamhet, fastän de utöva tandläkaryrket mot lag och förordning.

Man har emellertid icke bara ifrågasatt att legitimera dessa tekniker till ett utövande av tandläkaryrket inom mycket obestämda gränser, utan även att genom en särskild examensutbildning inrätta en lägre kvalificerad tandläkarkår. Men man bör observera, att en sådan examen och en sådan utbildning skulle draga ganska stora kostnader för staten, medan, som jag redan haft äran påpeka, även en mycket betydande höjning av antalet utexaminerade från tandläkarinstitutet skulle kosta så gott som ingenting alls.

Det mest avgörande skälet mot detta förslag, som framkommit ifrån herr Lovén i andra kammaren och herrar Boberg m. fl. i denna kammare, skulle enligt min mening vara — jag tager mig friheten att upprepa det något hårda men riktiga ord, som användes under debatten i andra kammaren — att det är reaktionärt och dessutom odemokratiskt. Det är reaktionärt, därför att det betyder en tillbakagång till en ståndpunkt, som vi för länge sedan passerat, då tandläkaryrket endast var ett hantverk. Och det är odemokratiskt, därför att det enligt tandteknikernas egen förklaring skulle ha till syfte att förse det fattigare folket i landet

med sämre tandvård och förbehålla den bättre tandvården åt de förmögnare. Tandteknikerna vilja visserligen själva icke erkänna, att deras tandvård skulle vara avsevärt sämre än tandläkarnas, men i herr Bobergs motivering säges det något om att man icke kan uppvisa, att det länt till någon skada för patienterna, att teknikerna praktisera såsom tandläkare. Jag ber då få framhålla, att, såsom redan framhållits i pressen, Stockholms rättshjälpsanstalt haft att uppvisa en mängd fall, då patienter, som blivit — man kan gärna använda det uttrycket — misshandlade av tandtekniker, sökt rättshjälpsanstaltens bistånd. Jag skall icke trötta kammaren med att uppläsa några fall, men om det är några av kammarens ledamöter, som önska få se detaljer, så har jag här en promemoria, som innehåller många sådana, delvis av ganska upprörande art. Jag vill naturligtvis icke komma här och påstå, att det icke även i fullt examinerade tandläkares praktik kan inträffa någon olyckshändelse, eller att icke även de kunna göra sig skyldiga till fusk på ett eller annat sätt, men därför att sådant kan inträffa även för de inom yrket häst kvalificerade bör man naturligtvis icke föreslå en sänkning av yrkesutbildningen, utan det bör tvärtom utgöra ett skäl för oss att ytterligare höja denna. Detta har också framhållits av tandläkarna själva på ett mycket energiskt sätt, och denne doktor Westin, som jag sett, att man citerat under andrakammardebatten och vilkens yttrande tagits till intäkt för tandteknikernas ståndpunkt, hade i själva verket endast detta syfte med sitt yttrande.

Jag ber alltså att såsom min mening få uttala, att på detta område liksom på andra är endast det bästa gott nog åt folket, och det är därför som vi reservanter ansett oss böra yrka bifall till vad andra kammaren i detta ärende beslutat. Jag hoppas att första kammaren nu skall fatta samma beslut, och jag får alltså instämma i herr Borells yrkande.

2. Erik Vrang (Första kammarens nationella parti, man)

Herr andre vice talman! Jag har till detta utskottsbetänkande fogat en blank reservation av den anledningen, att jag varken kunnat följa utskottsmajoriteten eller de båda reservanter, som avgivit skriftligt avfattad reservation.

Orsaken till att jag icke kunnat följa utskottzmajoriteten, är den, att det synes mig, som om utskottet vore inne på en mycket betänklig väg, då det vill hava en utredning, »huruvida och i vilken utsträckning den enklare tandvården må kunna anförtros även åt personer med lägre kvalifikationer».

Dessa stora betänkligheter ha påpekats för ett par år sedan av, bland andra, medicinalstyrelsen, som i ett yttrande av den 30 oktober 1921 med mycken styrka framhållit olämpligheten av att anförtro tandvården åt vetenskapligt underkvalificerade personer; jag skall tillåta mig att läsa upp ett par rader av vad medicinalstyrelsen då anförde. K. Styrelsen refererar till ett yttrande av sakkunniga och säger, att de sakkunniga hava härvid, d. v. s. vid sitt ingående på frågan om anordningar för offentlig tandvård, kommit till den åsikten, att det icke är önskvärt att söka lösningen på den frågan genom utbildande av en mindre kvalificerad kår, som endast skulle äga rätt att utöva konserverande tandbehandling. Styrelsen är i det avseendet av samma uppfattning, som erfarenheterna från andra områden få anses hava

ådagalagt, att det kommer att möta oöverskådliga hinder för såväl dessa yrkesutövare själva som för vederbörande myndigheter att begränsa deras verksamhetsområde.

Man får ock, om man har någon känsla för det ansvar, som måste vara förenat med tandläkarens uppgift, anledning att ställa sig högst betänksam och avvisande emot försöken att ställa underkvalificerade personer till förfogande för svenska folkets tandvård. Kan någon, som har den minsta kännedom om anatomi, histologi, kemi, fysik och bakteriologi vilja taga på sitt ansvar, att dessa oskolade tandteknici skola få hand om hälsan, i den mån den är lokaliserad till munhålan? Det är så mycket betänkligare att anförtro vården av munhålan åt personer, som hava föga insikt på detta område, som det ju är känt, att munhålan är en bakteriehärd, som måste behandlas med vetenskaplig erfarenhet för att skador icke skola onödigtvis uppkomma. Antiseptiken är ock ett viktigt spörsmål, som i detta sammanhang bör framhållas. Exempelvis gives på, hurusom en tandtekniker, som icke varit förfaren på detta område, har överfört syfilitisk sjukdom från ett sår på den ene patientens mun till den andres. Det är ruskigt att ens tänka på, vad man kan utsätta sig för genom detta, och det giver en allvarlig maning att icke uppmuntra ett upprepande härav.

Den motion, som här föreligger, syftar ju 1 första hand till att förbilliga tandvården, men jag tror, att jag icke missuppfattat motionen, om Jag säger, att den även i viss mån syftar till att låta dentisterna eller dessa — som jag kallar dem — underkvalificerade tandläkare få njuta frukterna av sitt arbete.

Det har sagts, att tandläkarna äro för dyra och att tandteknikerna, som skulle få licens att utöva tandläkaryrket, skulle bli så mycket billigare att svenska folket därigenom skulle få bättre och ändock fullt tillförlitlig tandvård. Det påminner mig i viss mån något om den lilla berättelsen om den, som kom till en tandläkare och fick betala 2 kronor för att få en tand utdragen men då invände: »Vad det var dyrt! Smeden där hemma tar inte mera än 25 öre!» Man har sagt och trott det också och till och med anfört det i motion, att tandläkarna taga så avsevärt betalt för sina tjänster åt allmänheten, att de därigenom, som man säger, klå allmänheten. Jag har förskaffat mig upplysning om hur härmed hänger samman, och jag vill till kammarens protokoll lämna några siffror 1 det avseendet.

Enligt 1922 års taxeringsuppgifter angående tandläkarnas inkomster visar det sig, att för hela riket, d. v. s. både stad och landsbygd, är det 24.3 Zz av kåren, som ha inkomster under 6,000 kronor, samt 22.8 4, som ha inkomster

mellan 6,000 och 10,000 kronor, och sålunda 47.1 Z av kåren, som ha en in- Ang. åstadkomst under 10,000 kronor. Därefter kommer en kategori, som har en års- ForEEnde a inkomst av mellan 10,000 och 15,000 kronor, och denna utgör 20.7 Z av hela lärd kåren. (Forts.)

Ser jag endast på förhållandena på landsbygden, ställer sig saken där ännu märkligare. Av de tandläkare, som där utöva sin verksamhet, är det 48.8 4 som ha en inkomst under 6,000

kronor, och 24.4 Z med en inkomst mellan 6,000 och 10,000 kronor, d. v. s. att något över 73 Z av tandläkarkåren på landsbygden har en årsinkomst av ej ens 10,000 kronor. Tager man nu hänsyn till den dyrbara utbildning, som tandläkarna få kosta på sig, och till den dyrbara uppsättning, som de måste skaffa sig, de studieskulder, som de sålunda måste underkasta sig att amortera, och vidare därtill, att de icke äro statstjänstemin eller tjänstemän i den ställningen överhuvud taget, att de kunna ha sin ålderdom betryggad genom pension, får man väl ändå anse, att dessa inkomster, som jag här nämnt, åtminstone icke äro för höga för personer, som hava denna utbildning.

Vad den saken beträffar, att det finns en del tandläkare, som taga för mycket betalt, så är det allmänhetens egen sak, om den uppsöker sådana. Vill allmänheten anlita en tandläkare, som har särskilt utbildat sig i någon viss gren av silt yrke, eller vill man begagna sig av en tandläkare, som kommit i ropet, ja, då vet man, att man får betala mera, men då får man ock skylla sig själv, om det blir dyrare än det behövt. Men icke skall väl, därför att allmänheten utsätter sig för onödigt dyra kostnader, den övervägande delen av kåren behöva bli lidande därför, och hela den vetenskapliga utbildningen, till förfång för både vetenskapen och patienterna, åsidosättas.

Jag vill i detta sammanhang meddela några andra siffror. Man skulle ju kanske tro, när man hör sägas, att tandläkarna taga så bra betalt för sina tjänster, att dentisterna skulle vara något slags mänsklighetens välgörare, som hava ringa inkomster. Jag har tagit några stickprov ur taxeringskalendern för Stockholm, och de visa, att en av dessa här praktiserande kvacksalvare på nu ifrågavarande område har en inkomst av mera än 21,300 kronor, en annan 25.200 kronor, en tredje 13,540 kronor, en fjärde 11,800 kronor, en femte omkring 11,000 kronor o. s. v. Jag tror, att när man får sådana upplysningar, skall kanske detta klander mot de höga tandläkartaxorna i någon mån **maka³** åt sig.

När man nu vill legitimera dessa tandteknici som tandläkare, så kan det hava ett visst intresse att erfara, vad för slags folk det är, som man har för avsikt att legitimera. Jag har i det fallet en utredning tillgänglig, såvitt jag vet den enda i sitt slag. Det framgår av denna, att av 65 stycken sådana tandteknici voro 8 guldsmeder, 2 före detta guldsmeder, 6 eller 7 verkstadsbiträden hos tandläkare, 3 barberare, 2 urmakare, 2 före detta barnmorskor, 1 litteratör, 1 skomakare, 1 folkskollärare, 1 timmerman, 1 före detta fotograf, 1 pianoarbetare och för övrigt 22 personer av okänt föregående yrke. Dessa vill man legitimera såsom tandläkare, visserligen kanske efter någon genomgången högre kurs, men i alla fall! Vad tror man följden skall bliva, om man, efter att ha berett dessa en föga tillfredsställande utbildning, släppte fram dem i munnen på folk? Jag tror man måste betacka sig för de utsikterna.

I Amerika, där som bekant förhållandena och formerna på skilda områden äro mycket friare än hos oss, är man mycket sträng emot den, som försöker utöva olaga tandläkarverksamhet. Kvacksalvare på detta område få där fängelsestraff för att de utöva sådant yrke. Här i Sverige tänker man legitimera dem och göra dem till tandläkare! Motsatserna äro alltför skriande. Det

sades för en kort tid sedan av en framstående amerikansk tandläkare, som besökte Sverige och beundrade de anordningar, som äro vidtagna vid vårt tand-

nuvarande förhållandena i Amerika. Vi berömma oss av vår höga kultur, men så ett, tu tre synes man vara beredd, åtminstone att döma av utskottsbetänkandet, att kasta oss 50—75 år tillbaka i tiden.

Jag kommer nu till den andra av anledningarna till att jag icke kunnat biträda utskottsförslaget. Visserligen ha herrar Borell och Pauli återkallat sin reservation och, med yrkande om uteslutande av viss del av motiveringen, anslutit sig till utskottets kläm, men den motivering, dessa båda herrar anfört, står kvar, och herr Pauli har i sitt anförande också påpekat, att han vid en eventuell utredning vill ha de synpunkter beaktade, som uttalats i hans och herr Borells reservation. Då det naturligtvis är att motse, att det protokoll över diskussionen, som här föres, skall komma att åtfölja ett eventuellt beslut om utredning, har jag även på den punkten velat anföra vissa betänkligheter. Det är här fråga om en institution, som skulle komma att i viss mån bli jämställd med stadsläkareoch provinsialläkarinstitutionerna. Även häremot har jag mina betänkligheter, och jag anser det vara lämpligt att uttala dessa redan på frågans nuvarande stadium.

Nu tror jag, att i den mån tankläkarkårens rekrytering kommer att ske i raskare tempo — det har ju här ställts i utsikt ett hundratal nya tandläkare om året — så kommer också tandvården både i städerna och på landsbygden att bli bättre tillgodosedd än den nu är, och på samma gång priserna på grund av konkurrensen mellan utövarna att sjunka. Men samtidigt blir det tillfälle för sådana kommuner, som anse sig vilja, kunna och behöva det, att på närmare håll träffa enskilda avtal om kommunal tandvård med tandläkare, som slå sig ned i de olika samhällena, utan att något statsingripande här i någon form behöver komma till stånd. Jag tror, att denna tandvård kommer att utveckla sig ute på landsbygden och i landsortsstäderna, likaväl som i de större städerna, statens hjälp och bön förutan, och då synes det mig heller icke vara behövligt, att någon statens åtgärd i detta stycke nu vidtages. Vi ha för övrigt ett ganska färskt exempel på, vad det kan leda till för konsekvenser, att staten påtager sig avgifter för olika sjukvårdsändamål. Det är icke så särdeles många år sedan, när landstingen fingo på sina skuldror lagt att, visserligen med statsbidrag, men ock genom uttaxering i länen, hjälpa till med att betala vårdkostnaderna för obemedlade eller mindre bemedlade sjuka. Denna sak har utvecklat sig i sådan riktning, att dessa kostnader hota att bli en av landstingens mera tyngande utgiftsposter. Jag har just i dagarna läst en uppsats i tidningarna om, att det lär vara fråga om att genom statsmakterna vidtaga åtgärder för att hämma det uppenbarliga missbruk, som här synes förekomma. Jag har anledning tro och befara, att vi, om staten som sådan ålägger sig kostnader för kommunal tandvård, skulle kunna få samma ogynnsamma erfarenheter även på detta område.

Jag hyser den uppfattningen, att bästa sättet — åtminstone ett mycket rekommendabelt och billigt sätt — är att låta barnen redan i skolorna få undervisning om, huru de lämpligen böra

vårda sina tänder för att hålla dessa friska, sålunda en rent profylaktisk åtgärd. Jag har mig bekant, att en pristävlan i detta stycke är utlyst i Svenska tandläkarsällskapet, avseende att få till stånd en populär skrift i saken, som sedermera skulle kunna vidarebefordras till lärarna vid olika skolor och genom dessa vidare ut till barnen. Det är det bästa sättet att råda bot mot dåliga tänder, att barnen få lära sig sköta

Med denna motivering, herr greve och talman, ber jag att få yrka avslag på utskottets föreliggande förslag.